DOCUMENTO FICTÍCIO — USO EXCLUSIVO EM TESTES — SEM VALIDADE CLÍNICA Fixture Q-PDF-MULTIPAGINA

RELATÓRIO DE ALTA HOSPITALAR

Relatório extenso com seis páginas

PACIENTE	Iracema Barbosa Teixeira	**IDADE**	74 anos
DOCUMENTO	DOC-Q-2026-0047	**DATA**	18/10/2026
ORIGEM	Enfermaria 6B		

PERÍODO DE INTERNAÇÃO

Admissão em 05/10/2026, alta em 18/10/2026 (13 dias).

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

Sepse de foco pulmonar — CID-10 A41.9.

RESUMO DA INTERNAÇÃO

Paciente internada com febre, tosse produtiva e rebaixamento do nível de consciência. Diagnosticada pneumonia com derrame parapneumônico, tratada com antibioticoterapia endovenosa por 14 dias e drenagem torácica.

EVOLUÇÃO — DIA 1

Dia 1 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 2

Dia 2 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 3

Dia 3 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 4

Dia 4 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 5

Dia 5 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

FICTÍCIO

DOCUMENTO FICTÍCIO — USO EXCLUSIVO EM TESTES — SEM VALIDADE CLÍNICA Fixture Q-PDF-MULTIPAGINA

EVOLUÇÃO — DIA 6

Dia 6 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 7

Dia 7 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 8

Dia 8 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 9

Dia 9 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

FICTÍCIO

DOCUMENTO FICTÍCIO — USO EXCLUSIVO EM TESTES — SEM VALIDADE CLÍNICA Fixture Q-PDF-MULTIPAGINA

EVOLUÇÃO — DIA 10

Dia 10 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 11

Dia 11 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 12

Dia 12 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 13

Dia 13 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 14

Dia 14 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 15

Dia 15 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 16

Dia 16 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 17

Dia 17 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 18

Dia 18 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 19

Dia 19 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

EVOLUÇÃO — DIA 20

Dia 20 de internação: paciente em antibioticoterapia endovenosa, hemodinamicamente estável, afebril nas últimas 24 horas. Controle laboratorial diário sem novas alterações significativas. Fisioterapia respiratória mantida. Aceitação parcial da dieta, diurese preservada e balanço hídrico equilibrado nas últimas 24 horas.

MEDICAÇÕES DE ALTA

Amoxicilina + clavulanato 875/125 mg — 1 comprimido por via oral a cada 12 horas, por 7 dias.

FICTÍCIO

DOCUMENTO FICTÍCIO — USO EXCLUSIVO EM TESTES — SEM VALIDADE CLÍNICA Fixture Q-PDF-MULTIPAGINA

ORIENTAÇÕES

Retorno em 7 dias com radiografia de controle. Sinais de alarme: febre, dispneia ou dor torácica.

Dr. Paulo Mendes Rocha
CRM 203114-RJ

FICTÍCIO